2.垂直压缩型骨折

①**Jefferson** 骨折：**C_1寰椎前后弓**双侧骨折（嬛嬛减肥），X 线很难发现骨折线、务必加做 **CT**。因骨折块多向椎管四周移位→**Halo 架**固定 12 周或**颅骨牵引**

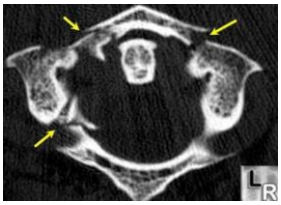
重叠在一起　　横断面

碎骨片往周围走，不易导致瘫痪



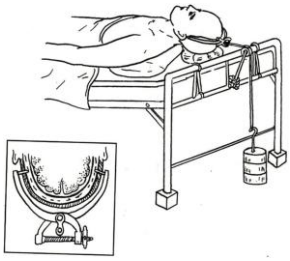


图 64-2 Jefferson 骨折





Halo架



②爆裂型骨折：C_3-C_7 粉碎性骨折　碎骨片有3块以上

一般直接做手术（碎骨片易进入椎管引起瘫痪）

3.过伸损伤

①**Hangman/缢死者**骨折：**C_2枢椎椎弓根**骨折（二叔上吊）。**无移位 Halo 架或牵引固定**；否则手术

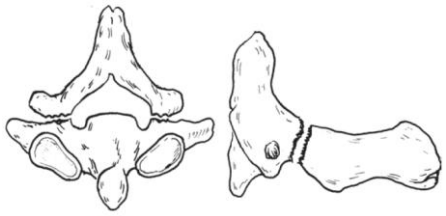
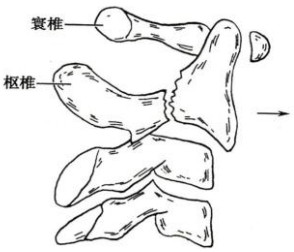


图 64-4 枢椎椎弓根骨折（缢死者骨折）



容易发生在高速急刹车时

②**无**骨折-脱位的过**伸**损伤如 **Whiplash 挥鞭**损伤：后路椎板成形术**扩大椎管容积**





图 64-3 颈椎过伸导致脊髓损伤

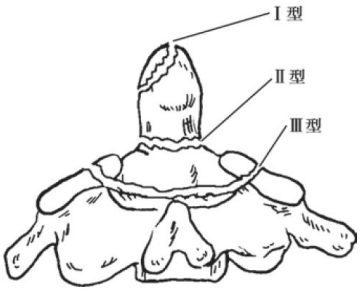
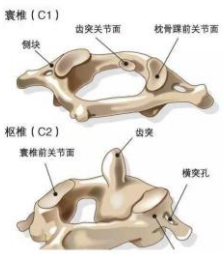


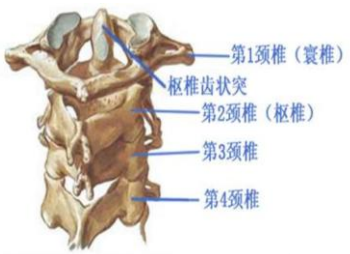
图 64-5 齿突骨折的分型

4.**齿状突**骨折：**Ⅰ、Ⅲ、无移位的Ⅱ型 Halo 架固定** 6-8 周（Ⅲ型固定 12 周）；否则手术　有移位的Ⅰ、Ⅱ型

（一山无二虎、神奇的 6-8 和 123）

5.寰-枢椎脱位：牵引复位后做寰-枢椎融合术　寰枢椎之间没有椎间盘，靠齿状突（“大鼻子”）就可以与第一颈椎连在一起





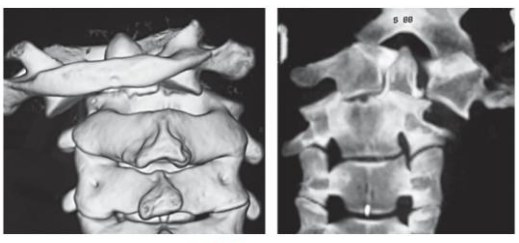


图 64-11 寰枢椎脱位

屈曲 → 压缩 / 脱位　　垂直压缩 → J / 爆　　过伸 → H / W　　齿状突骨折　　1-2椎体脱位

<1/3支具　　Halo架/颅骨牵引　　无移位牵引　　Ⅰ、ⅠⅠ、无移位的ⅠⅠ型 Halo架；

否则手术　　无椎间盘突出→手术　有…→先切椎间盘→手术　　手术　　有移位手术　　扩大椎管容积　　否则手术　　寰枢椎融合术

搞清楚类型→搞清楚要不要手术